TOME 04 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Cardiologie

Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC) • 509 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 04 : Cardiologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 509 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	509 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 04

Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 04 • Cardiologie (509 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Douleur thoracique (230)
- Chapitre 02 : Insuffisance cardiaque (234)
- Chapitre 03 : Athérome (221)
- Chapitre 04 : FR CV (222)
- Chapitre 05 : HTA (224)
- Chapitre 06 : Syndrome coronarien aigu (339)
- Chapitre 07 : Artériopathies et anévrismes (225)
- Chapitre 08 : Insuffisance veineuse chronique (227)
- Chapitre 09 : Ulcère de jambe (228)
- Chapitre 10 : MTEV (226)
- Chapitre 11 : Péricardite aiguë (235)
- Chapitre 12 : Électrocardiogramme (231, 236)
- Chapitre 13 : Fibrillation atriale (232)
- Chapitre 14 : Palpitations (237)
- Chapitre 15 : Malaise, perte de connaissance, crise convulsive (342)
- Chapitre 16 : Valvulopathies (233)
- Chapitre 17 : Endocardite infectieuse (152)
- Chapitre 18 : Porteurs de valve et prothèses vasculaires (153)
- Chapitre 19 : Anti-thrombotiques (330)
- Chapitre 20 : Anti-hypertenseurs (330)
- Chapitre 01 — Douleur thoracique (230)
- Dissection aortique
- Images TDM
- Score de probabilité clinique
- Prise en charge d’une dissection aortique
- Classification de DAILY ou de STANDFORD est la classification de référence, la classification de BAKEY est la plus ancienne
- Analyse sémiologique de la douleur thoracique

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Douleur thoracique (230)
Chapitre 02 : Insuffisance cardiaque (234)
Chapitre 03 : Athérome (221)
Chapitre 04 : FR CV (222)
Chapitre 05 : HTA (224)
Chapitre 06 : Syndrome coronarien aigu (339)
Chapitre 07 : Artériopathies et anévrismes (225)
Chapitre 08 : Insuffisance veineuse chronique (227)
Chapitre 09 : Ulcère de jambe (228)
Chapitre 10 : MTEV (226)
Chapitre 11 : Péricardite aiguë (235)
Chapitre 12 : Électrocardiogramme (231, 236)
Chapitre 13 : Fibrillation atriale (232)
Chapitre 14 : Palpitations (237)
Chapitre 15 : Malaise, perte de connaissance, crise convulsive (342)
Chapitre 16 : Valvulopathies (233)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Cardiologie

Critères	Paramètre 2	Cotation
Terrain évocateur	• Syndrome de Marfan • Antécédent familial de maladie aortique • Anévrisme de l'aorte thoracique ou pathologie valvulaire aortique connus • Antécédent de chirurgie aortique	1 point
Douleur thoracique évocatrice	• Douleur thoracique, dorsale ou abdominale de début brutal, intense et à type de déchirement	1 point
Signes évocateurs à l'examen clinique	• Abolition d'un pouls • Asymétrie tensionnelle • Déficit neurologique focal • Insuffisance aortique • Hypotension ou choc	1 point

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Cardiologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Définition	1. Pathologie exceptionnelle secondaire à une rupture de l'intima qui crée un orifice d'entrée, il existe alors un passage du sang de l'aorte normale vers un faux chenal -> survient alors un clivage entre la couche interne et externe de la média 2. Faux chenal peut alors progresser dans le sens antérograde ou rétrograde et atteindre les branches collatérales de l'aorte Il existe également un risque de rupture de l'aorte entraînant alors le décès
Terrain Facteurs favorisants	- HTA ancienne, Athérome : chez sujet âgé en général > 60 ans - Syndrome de Marfan ou d'Ehler Danlos : sujet plus jeune - ATCD familial de maladie aortique - Anévrisme de l'aorte thoracique, Pathologie valvulaire aortique connue - ATCD de chirurgie aortique
Douleur thoracique	Début thoracique aigu/brutal, intense, à type de déchirement, en « coup de poignard » (transfixiante) -> Irradiant dans le dos, migratrice, descendant vers les lombes et les membres inférieurs, parfois avec syncope
Signes cliniques	- Asymétrie tensionnelle (différence de > 20 mmHg), Abolition d'un pouls - Souffle d'insuffisance aortique (dans 50% des DA de type A) - Poussée d'HTA, ou Hypotension ou choc - Complications parfois révélatrices : -> Déficit neurologique (AVC) -> Infarctus médullaire (syndrome médullaire aigu), Hémopéricarde avec tamponnade -> Infarctus mésentérique, Ischémie aiguë d'un membre, Insuffisance rénale aiguë …
ECG	- Normal le plus souvent - Si extension à une artère coronaire : SCA (troubles de la repolarisation : sous-ST ou sus-ST ou inversion de l'onde T)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 04

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 04 • Cardiologie (509 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (509 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.